¨CONSTRUYAMOS UN PERÚ SALUDABLE¨



Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas




Foto: Municipio Distrital Cayaltia - Lambayeque

Perú, 2005

# PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

COMISION EUROPEA

MINISTERIO DE SALUD

Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud y
Aplicación en una Región del Perú
Convenio PER/B7-310/IB/97/209

Gobierno del Perú
Trabajo de peruanos

REPUBLICA DEL PERU

Ministerio de Salud

Personas que atendemos Personas

# PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
MINISTERIO DE SALUD
PERÚ - 2005

Catalogación hecha por el Centro de Documentación OPS/ OMS en el Perú

Programa de municipios y comunidades saludables / Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en Salud. -- Lima: Dirección General de Promoción de la Salud, 2005.
31 p.

CIUDAD SALUDABLE / PARTICIPACIÓN COMUNITARIA / IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SALUD / PLANES Y PROGRAMAS DE SALUD / LEGISLACIÓN SANITARIA / PROMOCIÓN DE LA SALUD / PERÚ

Hecho el Depósito Legal N° 2005-4660
ISBN 9972-2588-3-1

## Elaboración y revisión

Elvia Campos Zavala

Karina Gil Loayza

Laura Veramendi Benites

## Equipo de trabajo

Patricia Escalante Noriega

Víctor Raúl García Torres

Gladys Paco Echevarría

María del Carmen Parra Gallegos

César Torres Nonajulca

## Diseño y diagramación

Bessy Ormeño Coral

## Impresión

GMC Digital S.A.C.

MINISTERIO DE SALUD

No. 457-2005/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

# Resolución Ministerial

Lima, 15 de JUNIO del 2005

Visto, el Expediente N° 116028-04, que contiene la propuesta de la Dirección General de Promoción de la Salud, con relación al PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES;

**CONSIDERANDO**

Que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona;

Que el artículo 8° del Reglamento de Ley del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2002-SA, señala que el proceso de promoción de la salud, tiene como objetivo funcional lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social;

Que en concordancia con los Lineamientos de Política Sectorial 2002-2012 y en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud, la Dirección General de Promoción de la Salud ha desarrollado el documento técnico denominado: "Programa de Municipios y Comunidades Saludables" que comprende un conjunto de acciones de promoción de la salud en los municipios y las comunidades, a fin de impulsar el rol facilitador del personal de salud en los procesos de participación ciudadana así como en la generación de políticas públicas a favor de comportamientos y entornos saludables;

Que el Programa en mención, tiene como objetivo promover el desarrollo de municipios saludables y comunidades saludables, para contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad en concordancia con el proceso de descentralización; siendo por lo tanto, necesario contar con el Programa de Municipios y Comunidades Saludables, en el ámbito nacional;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Promoción de la Salud;

Con las visaciones del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo establecido en el inciso l) del artículo 8° de la Ley N 27657- Ley del Ministerio de Salud;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el **"PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES"**, la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2°.-** La implementación, ejecución y evaluación del PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES serán cumplidas a través de las Direcciones de Promoción de la Salud de las Direcciones Regionales de Salud, o las que hagan sus veces a nivel nacional.

**Artículo 3°.-** La Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria en Salud de la Dirección General de Promoción de la Salud, será la responsable de la difusión del presente programa, así como del monitoreo de su implementación a nivel nacional.

**Artículo 4°.-** Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación del presente Programa en la Página de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

**Pilar MAZZETTI SOLER**
**Ministra de Salud**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. ANA MARIA HOLGADO SALAMANCA
Secretaria General
Ministerio De Salud

24 JUN 2005

REPUBLICA DEL PERU

Ministerio de Salud

Personas que atendemos Personas

Señº ra
PILAR MAZZETTI SOLER
MINISTRA DE SALUD

Señº r
JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
VICE MINISTRO DE SALUD

Señº r
RICARDO BUSTAMANTE QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Señº ra
NELIDA DORÍS CÁCERES RAMÍREZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACION COMUNITARIA EN SALUD





# ÍNDICE

ÍNDICE


| Contenido | Página |
|---|---|
| Presentación | 9 |
| CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES | 11 |
| 1.1 Antecedentes y Justificación | 13 |
| 1.2 Base Legal | 15 |
| 1.3 Marco Conceptual de Promoción de la Salud | 15 |
| 1.4 Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud | 16 |
| CAPÍTULO 2: ASPECTOS ESPECÍFICOS | 17 |
| 2.1 Definición del Programa de Municipios y Comunidades Saludables | 19 |
| 2.2 Objetivos del Programa | 20 |
| 2.2.1 Objetivo General | 20 |
| 2.2.2 Objetivos Específicos | 20 |
| 2.3 Componentes y Escenarios de intervención | 20 |
| 2.3.1 Componente Programático Municipio | 20 |
| 2.3.2 Componente Programático Comunitario | 20 |
| 2.4 Actores del programa | 21 |
| 2.5 Líneas de Acción | 23 |
| 2.6 Organización para la Implementación | 23 |
| 2.6.1 Nivel nacional | 23 |
| 2.6.2 Nivel regional | 24 |
| 2.6.3 Nivel local | 24 |
| CAPÍTULO 3: ESTRATÉGIAS DEL PROGRAMA | 27 |
| 3.1 Estrategias del Programa | 29 |
| 3.2 Abogacía y Políticas Públicas | 29 |
| 3.3 Comunicación y Educación para la Salud | 29 |
| 3.4 Participación Comunitaria y Empoderamiento Social | 30 |
| CAPÍTULO 4: FASES DE IMPLEMENTACIÓN | 31 |
| 4.1 Fases de Implementación | 33 |
| 4.2 Para Municipios Saludables | 33 |
| 4.3 Para Comunidades Saludables | 34 |
| CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA | 37 |
| 5.1 Evaluación y Monitoreo del Programa | 39 |
| ANEXOS | 41 |
| Anexo N° 01 Glosario de Términos | 43 |
| Anexo N° 02 Cuadro de Descriptivo de Ejes Temáticos | 45 |
| Bibliografía | 47 |



# PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

La salud es el resultado de las interacciones de factores económicos, políticos, sociales y biológicos que superan el accionar del sector salud, allí aparecen las determinantes de la salud que condicionan la calidad de vida de la gente. Una comunidad sumergida en la pobreza difícilmente sus pobladores alcanzarán niveles adecuados de salud y de vida, así mismo, una población afectada por diversas carencias y enfermedades no será capaz de contribuir al desarrollo local de su comunidad.

El mayor desafío de Promoción de la Salud es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población motivando a sus autoridades públicas, privadas y a la población en general a construir municipios y comunidades saludables, como expresión de la participación ciudadana y ejercicio de los derechos y responsabilidades en salud. Para ello, es necesario adecuarse al proceso de descentralización y democratización de la salud, así como a la búsqueda del consenso para la movilización de recursos que promuevan entornos y comportamientos saludables.

Los municipios representan actualmente un gran potencial por su rol normador y promotor del desarrollo local, y porque intervienen en los determinantes de la salud, a través de sus programas municipales. Igualmente, las comunidades son un escenario fértil para la participación social en salud motivando el desarrollo de capacidades locales. Al sumar esfuerzos con los recursos, programas y servicios del sector salud potenciamos iniciativas que antes transitaron en forma aislada, pero que hoy pueden desarrollarse en forma complementaria y armonisa, propiciando políticas públicas saludables, entornos y comportamientos saludables en las personas, familias y comunidades.

El Programa de Municipios y Comunidades Saludables es una herramienta valiosa que contribuirá a implementar acciones de promoción de la salud en el escenario municipal y comunitario. El programa recoge las valiosas experiencias internacionales, regionales y locales, tanto de municipios y de comunidades saludables; y está planteado en el marco del modelo de abordaje de la promoción de la salud asumido por el Ministerio de Salud; la definición de sus contenidos se ha enriquecido con al aporte de las Direcciones de Salud e instituciones cooperantes que con sus sugerencias han contribuido en el diseño del mismo. Este documento contribuirá al diseño de herramientas, instrumentos y guías metodológicas para la implementación local de los componentes del programa.

Confiamos que el programa que presentamos estimule al personal de salud, alcaldes y líderes comunales a desarrollar acciones concretas que contribuyan al bienestar general y apoyen la atención conjunta de necesidades que mejoren la calidad de vida de nuestra población.

Dr. Ricardo Bustamante Quiroz



# CAPÍTULO 1
## ASPECTOS GENERALES

## 1.1 Antecedentes y Justificación

La Carta de Ottawa (1986), suscrita en Canadá, incorporó en el paradigma sanitario la promoción de la salud como estrategia para la comprensión de la salud como un recurso positivo para la vida y la construcción social. Desde esta perspectiva, la salud es resultante de un conjunto de determinantes[1] que inciden en la calidad de vida de las personas; por ello la promoción de la salud busca proporcionar a las personas, familias y comunidades, los medios y capacidades necesarias para incidir en los factores y/o determinantes de su salud, y poder ejercer de su derecho a la salud.

La promoción de la salud se desarrolla en lugares donde la gente vive, trabaja y se recrea, constituyendo estos los escenarios donde se gana o pierde salud[2] . En nuestro país, el nivel local jurídicamente establecido lo constituyen los municipios, siendo estos los escenarios en los cuales se deben fomentar políticas públicas saludables, programas y actividades vinculadas al tema sanitario. La participación comunitaria tiene un enfoque de derechos que se expresa con el ejercicio pleno de la ciudadanía; por ello se busca promover la generación de políticas públicas saludables, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la creación de entornos favorables para la salud, valorando las iniciativas y experiencias ya desarrolladas en los municipios y sus comunidades.

Alrededor del 80% de migrantes internos son menores de 34 años debido al desempleo, lo cual motiva una concentración de población en las ciudades restringiendo los servicios básicos, afectando las condiciones de salubridad y produciendo el hacinamiento y cambios de prácticas en la vida de las personas. Además, el 60% de la población rural no tiene agua segura, elemento indispensable para la vida. En el país se reporta que el 41% de mujeres unidas ha sufrido maltrato, el 25% de niños padece desnutrición crónica y alrededor de 613,000 niños de escuela primaria repiten o desertan cada año. Esto sumando a un 55% de peruanos que vive en pobreza y 24.4% en pobreza extrema nos muestra que estas condiciones de vida afectan la salud de población cuyas soluciones superan el quehacer único del sector salud, comprometiendo a otros actores como los gobiernos locales y organizaciones comunales.

El Perú esta en un proceso hacia la democratización y descentralización el cual es acompañado por los diversos sectores; por ello el sector salud hace énfasis en la adecuación de sus roles a escenarios más amplios de intervención, promoviendo el cambio del paradigma de la salud, del esfuerzo por control del daño hacia la promoción de lo saludable. Es así que el Ministerio de Salud desarrolla el Programa de Municipios y Comunidades Saludables enmarcado en los Lineamientos de Política del Sector 2002-2012, Modelo de Atención Integral de Salud, que ubican a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como una prioridad sectorial y las Estrategias Sanitarias Nacionales. La legislación actual sobre descentralización[3] de los gobiernos regionales[4] , locales[5] y del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud[6] , amparan su implementación.

En este sentido, para el Ministerio de Salud, Municipios y Comunidades Saludables es un programa que se orienta a fortalecer o crear las condiciones favorables para desarrollar acciones de promoción de la salud enmarcadas en el Modelo de Atención

[1] Para mayor detalle ver anexo, definición de términos.
[2] Estrategia de municipios y comunidades saludables de OPS-OMS.
[3] Ley de Bases de la Descentralización N 287783- Art.36
[4] Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N 27867 Art.49
[5] Ley Orgánica de Municipalidades N 27972 Capítulo V, Título V
[6] Ley SNCDS N 27813 Art.8 y 10.

Integral de Salud; con acciones integrales e integradas sobre los determinantes de la salud dirigidos hacia el desarrollo de la comunidad, propiciando el compromiso de las autoridades municipales, instituciones y en espacios de concertación insertándolos en agenda pública; en concordancia al proceso de descentralización y democratización.

En 1996, el Ministerio de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, desarrolla las primeras acciones para impulsar las comunidades saludables[7], [8] a partir de la celebración del Día Mundial de la Salud, motivando la firma de una "Declaración de la Iniciativa de Comunidades Saludables" por instituciones, organismos sociales de base, entidades de la sociedad civil, la comunidad universitaria y municipios constituyéndose en el buen inicio de la conformación de una Red de Municipios y Comunidades Saludables; sin embargo, la implementación tuvo un carácter operativo desde el nivel nacional sin articulación con el nivel regional.

Desde 1999, se desarrollan una serie de eventos para el intercambio de experiencias con municipios de Tumbes, Piura, Arequipa, Huaura y Cajamarca, y talleres para la planificación estratégica de promoción de la salud con los municipios cuyo producto fue el Plan Estratégico 2002 - 2005 de la Red de Municipios y Comunidades Saludables de Lima y Callao, los cuales han sido valorados como insumos para el diseño del programa.

Con la creación de la Dirección General de Promoción de la Salud, la implementación adopta un carácter nacional, y se incorpora al Plan Estratégico de Promoción de la Salud 2003 - 2006 como una línea de acción, además con ocasión del Taller Nacional de Promoción de la Salud 2003, se establecieron 10 DISAS pilotos[9] para la implementación inicial del programa.

Paralelamente, se conforma la Red de Municipios y Comunidades Saludables, integrada por 30 municipios de Lima y Callao, cuya secretaría técnica es asumida por la Dirección General de Promoción de la Salud - MINSA, contando con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y agencias cooperantes en el marco de alianzas estratégicas a fin de promover políticas municipales saludables en algunos ejes temáticos tales como: violencia familiar, cultura de tránsito, medio ambiente, y otros.

Durante el año 2003, se realizaron talleres sobre Políticas Municipales Saludables de Juventud, de Mujer y Equidad de Género, y Adulto Mayor, en el marco de las actividades de la Red de Municipios y Comunidades Saludables, los cuales reunieron a alcaldes, regidores y sociedad civil para un análisis y discusión de propuestas consensuadas de legislación municipal a favor de la población.

Por otro lado las Direcciones Regionales de Salud han realizado talleres macro regionales y encuentros de alcaldes en Apurímac, Huanuco, Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cajamarca, La Libertad, Ica, Lambayeque, Lima Sur, Lima Este y Lima Norte, entre otros. Logrando incorporar las actividades del programa en los planes regionales de salud, en los presupuestos participativos y en los planes de desarrollo comunales, distritales o provinciales; siendo el nivel de avance del programa diverso a nivel nacional, ya que obedece a procesos de socio-políticos.

[7]Intercambio de Experiencias en Municipios y Comunidades Saludables en el Perú. OPS-2000.
[8]Informe Memoria: Red de Municipios y Comunidades Saludables de Lima y Callao, Taller de Planificación Estratégica.2001.
[9]Lima Sur, La Libertad, Loreto, Huanuco, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac I, Apurimac II, Ucayali y Tumbes

## 1.2 Base Legal

La implementación del Programa de Municipios y Comunidades Saludables se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas:

1. Constitución Política del Perú
2. Ley General de Salud, N° 26842
3. Ley del Ministerio de Salud, N° 27657
4. Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud, Decreto Supremo N° 013-2002-SA
5. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Nş 27867
6. Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, Nş 27813
7. Ley de Bases de Descentralización, Nş 27783
8. Ley Orgánica de Municipalidades, Nş 27972
9. Modelo de Atención Integral de Salud, RM Nş 729-203 SA/DM
10. Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002-2012.

## 1.3 Marco Conceptual de Promoción de la Salud

La salud es entendida como el producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales que suceden en la sociedad. Por ello el vínculo entre salud y desarrollo es fundamental y recíproco. La salud entonces, es el resultado del nivel de desarrollo de una sociedad por cuanto éste determina la disponibilidad de recursos para el bienestar general de la población. Por otro lado, la salud es condición necesaria para el desarrollo social por la repercusión que tiene en la capacidad de trabajo del individuo y el establecimiento de la tranquilidad y progreso social que el desarrollo requiere[10].

La promoción de la salud contiene un gran potencial para afrontar los desafíos en materia de salud que enfrenta el país. Son procesos que buscan desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos políticos, organizativos y administrativos que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades, y poder cambiar o hacer frente a su entorno[11].

En este marco conceptual los lineamientos de política de promoción de la salud propuestos son:

1. Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud.
2. Mejorar las condiciones del medio ambiente.
3. Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía.
4. Reorientar los servicios de salud con enfoque de promoción de la salud.
5. Reorientación de la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo local.

[10] Programa de Acción: Comunidades Saludables. Secretaría de Salud de México. 2002.
[11] Consejo Nacional de Salud. Propuesta de Lineamientos de Política de Promoción de la Salud. 2003.

## 1.4 Mº delº de Abº rdaje de Prº mº ción de la Salud en Perú

La implementación del prº grama de municipiº s y cº munidades saludables se enmarca en el mº delº de abº rdaje de Prº mº ción de la Salud del Ministeriº de Salud, el cual plantea cº mº sujetº s de intervención a: la persº na, la familia y la cº munidad, prº mº viendº entº rnº s saludables en lº s escenariº s: vivienda, escuelas, municipiº s y cº munidades, así cº mº en lº s centrº s labº rales. En ellº s se desarrº llan ejes temáticº s a través de enfº ques de equidad y derechº s en salud, equidad de génerº e interculturalidad y de estrategias transversales de: abº gacía y pº líticas públicas, cº municación y educación para la salud, participación cº munitaria y empº deramientº sº cial que cº ntribuyan a la calidad de vida de la pº blación.

Lº s enfº ques y estrategias brindan la º rientación que tendrán las acciº nes e implican una nueva mirada de valº ración, respetº, prº tección a lº s derechº s y fº mentº de prácticas lº cales y tradiciº nales de la pº blación en general y de las cº munidades indígenas y nativas además de su inclusión en lº s prº cesº s de decisión lº cal[12].

Figura Nº1: Mº delº de Abº rdaje de Prº mº ción de la Salud

| ENFOQUES TRANSVERSALES | ESTRATEGIAS | POBLACION SUJETO DE INTERVENCION | | | | | ESCENARIOS (entornos saludables) | EJES TEMATICOS (comportamientos saludables) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIDAD Y DERECHOS EN SALUD | ABOGACIA Y POLITICAS PUBLICAS | FAMILIA | INDIVIDUO POR ETAPAS DE VIDA | | | | VIVIENDA | ALIMENTACION Y NUTRICION |
| | | | NIÑO | ADOLESCENTE | ADULTO | ADULTO MAYOR | | HIGIENE Y AMBIENTE |
| | | | | | | | | ACTIVIDAD FISICA |
| EQUIDAD DE GENERO | COMUNICACION Y EDUCACION PARA LA SALUD | COMUNIDAD | | | | | INSTITU-CIONES EDUCATIVAS | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
| | | | | | | | | HABILIDADES PARA LA VIDA |
| INTER CULTURALIDAD | PARTICIPACION COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL | | | | | | MUNICIPIOS | SEGURIDAD VIAL Y CULTURA DE TRANSITO |
| | | | | | | | CENTROS LABORALES | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL, BUEN TRATO Y CULTURA DE PAZ |

Un prº grama esta determinadº pº r el escenariº de intervención y lº s ejes temáticº s priº rizadº s; a través del cual se º rganizan y se implementan las acciº nes, teniendº en cuenta lº s enfº ques y ejes transversales en su diseñº.

[12] Para el prº grama, lº "lº cal" es el micrº espaciº de la cº munidad más cercanº a la pº blación según el cº mpº nente.

# CAPÍTULO 2
## ASPECTOS ESPECÍFICOS



## 2.1 Definición del Programa de Municipios y Comunidades Saludables

Un programa esta determinado por el escenario de intervención y los ejes temáticos priorizados; a través del cual se organizan y se implementan las acciones, teniendo en cuenta los enfoques y ejes transversales en su diseño.

El programa de Municipios y Comunidades Saludables, es un conjunto de líneas de acción para la promoción de la salud en los escenarios del municipio y comunidad, que involucra a diversos actores y redes sociales liderados por el gobierno local a fin de contribuir al proceso de mejora de la calidad de vida de la población, desarrollando acciones, creando entornos y comportamientos saludables a favor de la comunidad; para lo cual es esencial, la generación de políticas públicas, la inserción de la promoción de la salud en la agenda pública, la participación ciudadana, la co-responsabilidad intersectorial y el desarrollo de alianzas estratégicas que propicien el bienestar de la población en concordancia con las políticas nacionales, regionales y locales.

Para mejor comprensión del programa se definen algunos términos esenciales:

***a) Municipalidad.-*** Es la instancia administrativa descentralizada de gobierno local más cercano a la población, es el articulador entre la sociedad y el Estado; como responsable del desarrollo local tiene entre sus competencias promover el desarrollo económico y social a través de la educación, cultura, salud, deporte y recreación; saneamiento, ambiente y vivienda; y participación vecinal, entre otros; que influyen sobre la calidad de vida de la población.

***b) Municipio.-*** Es la demarcación territorial adscrita a la municipalidad, en el que viven las personas, familias y conforman comunidades, establecen redes sociales y relaciones entre sus miembros con igual o diversas problemáticas. Comprende además los espacios públicos, servicios públicos entre otros. En el programa se empleará el término municipio porque alude al escenario y las interrelaciones que se desea propiciar a partir de una intervención específica.

***c) Comunidad.-*** Se define como el conjunto de personas que comparten una cultura, objetivos comunes y que viven en un mismo espacio geográfico. Se ubican tanto en áreas urbanas y rurales. La definición incluye todas las formas de agrupaciones existentes en la sociedad.

***d) Municipio Saludable.-*** Es un espacio territorial en el cual las políticas públicas han consolidado entornos y propiciado comportamientos saludables en las personas, familias y comunidades; con la participación activa de sus autoridades políticas y civiles, instituciones, organizaciones públicas, privadas y comunidad organizada para contribuir al desarrollo local.

***e) Comunidad Saludable.-*** Es aquella comunidad, con capacidades para tomar decisiones, negociar e intervenir y resolver sus problemas de salud y proyectarse hacia el desarrollo integral de la comunidad[13] .

[13] Adaptado a la definición de OPS

## 2.2 Objetivos del Programa

### 2.2.1 Objetivo General

Promover el desarrollo de municipios y comunidades saludables, para contribuir con la generación de entornos y comportamientos saludables en los escenarios del municipio y la comunidad; propiciando la participación, el compromiso y la decisión de las autoridades municipales, la comunidad organizada y otros actores que conduzcan a la generación de políticas públicas saludables en concordancia con el proceso de descentralización.

### 2.2.2 Objetivos Específicos

a. Fortalecer competencias del personal de salud, autoridades locales y municipales, líderes, organizaciones sociales y civiles; para facilitar el proceso de implementación del Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

b. Promover el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y articulación entre el gobierno local, comunidad organizada y las organizaciones sociales, para incorporar las políticas públicas saludables en la agenda de los diferentes actores sociales.

c. Fomentar el desarrollo de programas, proyectos, planes municipales y comunales de salud integral y desarrollo local, en el proceso de descentralización, que actúen sobre los problemas y determinantes de la salud identificados y priorizados a nivel local.

## 2.3 Componentes y Escenarios de intervención

Para fines de programación y de intervención, el programa se divide en dos componentes programáticos:

### 2.3.1 Componente Programático Municipio

Está referido a la generación de municipios saludables, es decir, incorporar acciones de promoción de la salud en la agenda del gobierno municipal, en el marco del desarrollo local.

### 2.3.2 Componente Programático Comunidad

Esta orientada a la generación de comunidades saludables, es decir, incorporar acciones de promoción de la salud y de desarrollo en la agenda comunal. Implica la vigilancia de situaciones o hechos que afectan las condiciones de una vida saludable en la comunidad[14]; permitiendo contar con información veraz y oportuna para intervenir efectivamente con acciones de promoción de la salud y protección de la salud.

Cada componente tiene escenarios particulares donde se realizan intervenciones específicas y se desarrollan los ejes temáticos[15], pudiendo ser complementarias entre ambas, estos son:

[14] Hace referencia al sistema de vigilancia comunal
[15] Ver anexos

***En el municipio***, se identifican lº s siguientes escenariº s:

- ***La municipalidad:*** Instancia del gobierno local en cuya infraestructura y dinámica organizacional se pueden generar entornos saludables a través de políticas municipales saludables con acciones institucionalizadas de promoción de la salud en el plan institucional, tales como: municipalidades con ambientes libres de humo de tabaco, adecuación arquitectónica para discapacitados, señalización para evacuación en casos de desastres, entre otros.

- ***Espacios públicos:*** Son lugares a disposición de la colectividad como los espacios de recreación y esparcimiento (parques, plazuelas y malecones), lugares que brindan servicios públicos (mercados, restaurantes, etc.), así como los barrios, sectores, etc. donde pueden realizarse acciones concretas como mercados saludables, restaurantes saludables, campañas municipales de limpieza de techos, barrido de calles, etc.

***En la comunidad:*** Se identifican los siguientes escenarios:

- ***En zonas urbanas:*** Urbanizaciones, asociaciones, barrios, entre otros.

- ***En zonas urbano marginales:*** Asentamientos humanos, Asociaciones de pueblos jóvenes, entre otros.

- ***En zonas rurales:*** Centros poblados menores, anexos, caseríos, fronteras, comunidades campesinas, entre otros.

## 2.4 Actº res del prº grama

Existen diversos actores sociales esenciales que interactúan bajo el propósito de desarrollar acciones, planes y políticas a favor de la población.

- ***Municipio:*** Representado por el Alcalde, regidores, funcionarios, entre otros. Asume el liderazgo en la implementación del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, una vez sensibilizado y comprometido. Promueve la concertación y articulación de los recursos[16] existentes para promover el desarrollo local, basado en la capacidad de convocatoria en el marco de sus competencias. Norma a través de ordenanzas, acuerdos y decretos de alcaldía, como expresión de políticas públicas saludables en concordancia a la normatividad de salud.

- ***Comunidad:*** Representado por autoridades comunales (asamblea comunitaria, junta directiva), agentes comunitarios de salud, asociaciones de pobladores, organizaciones sociales de base (Programa de vaso de leche, comedores populares, club de madres), entre otros. La comunidad motiva al municipio a intervenir en aspectos de salud, canaliza iniciativas, demandas y necesidades de la población ante las autoridades municipales, promoviendo la formulación e implementación de políticas públicas saludables. Propicia la participación comunitaria hacia el ejercicio de la ciudadanía, promoviendo mecanismos de encuentro, diálogo y coordinación con las autoridades municipales, comunales, redes sociales y la población ejerciendo la vigilancia ciudadana en salud. Representa el soporte básico porque su participación permanente brinda la sostenibilidad.

[16] Recursos: Referido a los recursos humanos, financieros, naturales, materiales (equipos, infraestructura o espacios) y otros.

- ***Personal de Salud:*** Representado por el personal de salud de los diferentes niveles de organización (DIRESA, red, microred, establecimiento). Actúa como facilitador del proceso, generando las condiciones adecuadas entre el Sector Salud, municipio, comunidades y otros actores públicos y privados; articulando recursos y brindando el acompañamiento permanente en todo el proceso en la implementación y la evaluación. Además, adecua la normatividad técnica del programa a la realidad local y propone iniciativas en concordancia con los lineamientos de política de promoción de la salud y la realidad sanitaria local.

- ***Otros Sectores Públicos y Privados:*** Representado por otros sectores públicos como Educación, Agricultura, Pesquería, Fuerzas Armadas, del Interior, etc. existentes en la comunidad o el municipio. A través de sus programas y políticas realizan acciones complementarias con salud y desarrollo pudiendo sumarse a los actores mencionados.

Los sectores privados están constituidos por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), proyectos y agencias de cooperación, universidades, comerciantes locales, medios de comunicación, etc.

La participación de las mesas de concertación distrital o provincial son de vital importancia para facilitar la coordinación intersectorial y apoyar relaciones y acuerdos entre los diversos sectores y actores para alcanzar metas comunes.

Promover municipios y comunidades saludables supone el encuentro y la articulación de todos estos actores para establecer alianzas estratégicas en una política de trabajo intersectorial permanente. Es preciso que todos los actores sean convocados e incluidos como sujetos potenciales.

Figura N°2: Principales actores y roles del Programa de Municipios y Comunidades Saludables



## 2.5 Lineas de Acción

Se plantean tres líneas de acción:

- ***Fortalecimiento de competencias:*** Está referido a desarrollar y/o potenciar las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de los actores involucrados en forma permanente. Están orientadas a atender las necesidades de salud como parte del desarrollo local, las que deberán traducirse en acciones encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

- ***Vigilancia Ciudadana:*** Referida a la promoción de acciones de fiscalización, control, transparencia y empoderamiento de la persona, familia y comunidades empleando los mecanismos municipales, regionales y comunitarios para alcanzar su ejercicio permanente.

- ***Fomento de proyectos/programas vinculados a la promoción de la salud:*** Referida a impulsar proyectos o programas municipales y comunitarios relacionados a salud, educación, participación comunitaria y producción; así como apoyar técnicamente su negociación y ejecución; los cuales podrían institucionalizarse en el plan municipal o comunal. Algunos ejemplos son: mercado saludable, proyecto de saneamiento básico, bibliotecas municipales, reciclaje intradomiciliario de residuos sólidos, cocinas mejoradas y biohuertos, entre otros.

## 2.6 Organización para la implementación

### 2.6.1 Nivel nacional: Dirección Ejecutiva de Participación Comunitaria de la Dirección General de Promoción de la Salud

- Elaborar lineamientos técnico-normativos y planes con la finalidad de implementar las Acciones de Promoción de la Salud en los escenarios de municipios y comunidades.

- Diseñar y planificar el monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de implementación del Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

- Brindar asistencia técnica a los equipos responsables de Participación Comunitaria en Salud de las Direcciones de Salud.

- Fortalecer las competencias de los equipos regionales para la implementación del programa.

- Facilitar y articular la conformación de redes sociales y espacios de concertación que consoliden los procesos de implementación del programa en las Direcciones de Salud.

- Sistematizar y socializar de experiencias locales del Programa de Municipios y Comunidades Saludables que apoyen las evidencias en promoción de la salud.

- Propiciar el desarrollo de investigaciones operativas que contribuyan a fº rtalecer el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

- Establecer acuerdos y convenios con agencias cooperantes, proyectos y otros sectores que trabajan en la temática para contar con apoyo técnico y financiero que permita operativizar acciones del programa.

### 2.6.2 Nivel Regional: Direcciones de Salud

- Gestionar las acciones de promoción de la salud y participación comunitaria mediante procesos participativos con las autoridades regionales, locales y comunitarias contempladas en el programa.

- Difundir los lineamientos técnico-normativos y directivas relacionados al programa con los gobiernos regionales, locales, representantes de las comunidades, y otros actores.

- Establecer niveles de coordinación e integración de las acciones con los programas de promoción de la salud.

- Concertar alianzas estratégicas con las instituciones y organismos que apoyen la inversión y ejecución de acciones específicas del programa.

- Brindar el apoyo técnico, administrativo, político y financiero a las redes de salud que implementan el programa.

- Proponer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo para la implementación del programa mediante la elaboración de planes y estrategias regionales con participación ciudadana.

- Capacitar y brindar asistencia técnica al equipo técnico de salud que facilite el proceso de implementación del programa a nivel local.

- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones de promoción de la salud incorporadas al programa en los niveles correspondientes.

- Desarrollar investigaciones operativas que contribuyan a fortalecer el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

- Recopilar y consolidar información de las redes y remitirla al nivel nacional, y efectuar la retroalimentación respectiva.

### 2.6.3 Nivel Local: Direcciones de Red de Servicios de Salud, Microrredes y/o Establecimientos de Salud.

.

- Operativizar las acciones del programa entre la red, microrred o establecimiento según sea el caso y el municipio o comunidad seleccionada en coordinación con los actores involucrados y en concordancia con las instancias de descentralización existentes a nivel provincial y distrital.

- Identificar interlocutores y establecer niveles de organización y coordinación con los gobiernos locales, líderes comunales, organismos e instituciones públicas y privadas para la implementación del programa a través de los Comités Multisectoriales o Comités Comunales o similares.

- Desarrollar acciones de abogacía y sensibilización a las autoridades de los gobiernos locales, regionales, líderes comunitarios y otros actores sociales en el proceso de implementación del programa.

- Promover la generación de políticas públicas saludables y la incorporación de acciones de promoción de la salud en la agenda municipal y comunal a través de procesos participativos.

- Incorporar en el Plan Operativo Institucional las actividades orientadas a garantizar la implementación y ejecución del Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

- Efectuar el acompañamiento técnico a los comités multisectoriales y comunales para la implementación y evaluación de programas y proyectos municipales o comunales.

- Informar el avance de acciones realizadas en el proceso de implementación y desarrollo del Programa de Municipios y Comunidades Saludables a las instancias respectivas.

- Retroalimentar oportunamente de los avances y logros del programa, a los diferentes actores sociales, instituciones y espacios políticos involucrados.

- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones de programa a nivel comunitario y municipal.

- Desarrollar investigaciones operativas que contribuyan a fortalecer el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.

- Sistematizar las experiencias demostrativas en el proceso de implementación y desarrollo del programa de Municipios y Comunidades Saludables.

# CAPÍTULO 3
## ESTRATEGÍAS DEL PROGRAMA

## 3.1 Estrategias del Programa

En el modelo de abordaje de promoción de la salud se establecen los enfoques transversales de equidad y derechos en salud, equidad de género e interculturalidad que orientan la promoción de la participación comunitaria hacia el ejercicio de la ciudadanía en salud a través del acceso y la capacidad de informarse, de la igualdad de oportunidades y derechos en hombres y mujeres, así como el respeto a las diferencias étnicas y religiosas.

Con el propósito de empoderar a los municipios, comunidades, gobiernos regionales y demás actores para que desarrollen acciones y políticas de promoción de la salud desde sus propios escenarios y competencias, se establecen las siguientes estrategias.

## 3.2 Abogacía y Políticas Públicas

Para alcanzar una buena calidad de vida, se necesita de políticas que garanticen estas condiciones y se requiere una acción estatal integral y articulada para la solución de los diversos problemas que respondan a los intereses y necesidades de la población.

Las políticas públicas son aquellas decisiones políticas del sector público: gobierno local, regional y otros sectores plasmados en ordenanzas, resoluciones, planes concertados de desarrollo, presupuestos participativos, entre otros, que tienen una fuerte influencia sobre los determinantes de salud e implica inversión de recursos. De acuerdo a su contenido, pueden ser saludables cuando tiene por objetivo favorecer la salud, y por lo general emanan de otros sectores diferentes a salud.

La abogacía es una estrategia de la promoción que combina acciones individuales y sociales, destinadas por un lado a superar resistencias, prejuicios y controversias y por otro lado, a conseguir compromisos y apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud.

La abogacía es hacer pública una idea o propuesta, es llamar la atención de la comunidad y de quienes toman decisiones sobre un problema o tema de importancia, para ponerlo en agenda y actuar sobre éste y sus soluciones.

## 3.3 Comunicación y Educación para la Salud

Para construir procesos eficaces para el desarrollo de comportamientos saludables, es necesario aplicar metodologías de educación y comunicación a la población sujeto de intervención a nivel individual, familiar y comunal, en los diferentes escenarios, diferenciando los tipos de actores para elegir las técnicas y estrategias más adecuadas que faciliten la comprensión de los contenidos. Comprende actividades educativas que hagan sinergia con las actividades de comunicación para ampliar conocimientos en la población y en los decisores para el desarrollo de habilidades para adoptar las mejores decisiones a favor de la salud.

## 3.4 Participación Comunitaria y Empoderamiento Social

La participación comunitaria es el proceso mediante el cual los individuos y las familias asumen la capacidad de contribuir a su propio desarrollo y al de su comunidad. Para que los individuos, familias, grupos comunitarios y decisores participen efectivamente, es necesario que sean consultados e intervengan en sus propias decisiones.

El empoderamiento social, supone que los individuos, familias, grupos comunitarios y decisores actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo un importante objetivo de la acción comunitaria en salud.

En el Programa de Municipios y Comunidades Saludables, la participación comunitaria es el soporte básico, que brinda el sostenimiento de los procesos de desarrollo local y la habilitación de capacidades y mecanismos que garantizan el ejercicio de los derechos y responsabilidades en salud. Bajo esta concepción la participación comunitaria conduce al ejercicio de la ciudadanía y el empoderamiento social.

# CAPÍTULO 4
## FASES DE IMPLEMENTACIÓN



## 4.1 Fases de Implementación

El programa tiene cinco fases secuenciales, tanto para el componente de municipio y para el componente de comunidad, estos son: sensibilización, organización, planificación, participativa, ejecución, seguimiento, y evaluación participativa, esta última como una fase transversal.

Figura Nº3: Fases de Implementación del Prº grama de Municipiº s y Cº munidades Saludables




## 4.2 Para Municipiº s Saludables

***PRIMERA FASE: Sensibilización.-*** Esta fase esta referida a la identificación de los municipios en la jurisdicción de la Dirección de Salud, para la implementación del programa. Comprende la capacitación al personal de salud de la Red/Microrred/establecimiento de salud involucrado, identificación y sensibilización de autoridades y funcionarios de los gobiernos locales seleccionados y representantes de la comunidad organizada hasta alcanzar la firma del Acta de Compromiso para implementar y desarrollar Municipios y Comunidades Saludables. Al finalizar esta fase se realiza la primera calificación de municipios saludables.

**SEGUNDA FASE: Organización.-** Comprende la conformación del Comité Multisectorial distrital o provincial (representantes de la Municipalidad, comunidad organizada y el personal de salud) responsable de la organización, planificación y evaluación de todo el proceso de implementación del programa definiéndose responsabilidades en cada uno de los integrantes. El producto de esta fase es la instalación del Comité Multisectorial distrital o provincial según sea el caso. De existir una instancia similar, se adecuará la incorporación de nuevas responsabilidades.

**TERCERA FASE: Planificación Participativa .-** Implica la elaboración y aprobación del Plan Concertado (distrital o provincial) que contiene acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en el escenario municipal, el cual deberá articularse con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Salud Local. Este Plan Concertado refleja la realidad local en todas sus dimensiones, es producto de una construcción participativa e intersectorial, en la cual igualmente contribuyeron con sus aportes representantes de ONG's que trabajan la temática, universidades, institutos superiores locales, la asociación de agentes comunitarios o similar, mesas de concertación, representantes del sector educación, agricultura, y otros actores sociales. Cabe recalcar, que la construcción del plan en mención parte de un diagnóstico de salud, en el cual se priorizan las demandas y necesidades sociales influyentes en la calidad de vida de la población. Es importante mencionar que estos planes igualmente integran programas y/o proyectos específicos, los cuales se han elaborado con la finalidad de dar respuestas a las demandas y necesidades sociales. Al finalizar esta fase se efectúa la segunda calificación.

**CUARTA FASE: Ejecución.- Se refiere a la ejecución del plan concertado, el cual puede estar reflejado en programas y/o proyectos específicos de promoción de la salud que pueden desarrollarse en los escenarios municipales o en los ámbitos de intervención de las instituciones y mesas de concertación que participan del programa. Es importante impulsar a que las iniciativas se institucionalicen, que se plasmen en políticas municipales saludables y que ingresen a la agenda municipal. En esta fase es importante el acompañamiento técnico y político a fin de impulsar la continuidad de las acciones emprendidas. En esta fase se realiza la tercera calificación.**

**QUINTA FASE: Seguimiento y Evaluación Participativa.-** Esta fase es transversal a todas y se aplica en todo el proceso de implementación del programa, mediante el uso de instrumentos e indicadores cuantitativos y cualitativos de proceso y de resultado para conocer los avances, factores que facilitan y/o limitan la ejecución del Plan Concertado. Esta fase se realiza a través del Comité Multisectorial y deberá considerar la sistematización de experiencias locales para la socialización de logros y lecciones aprendidas.

Al finalizar esta fase, el personal de salud promoverá la elaboración de un documento de sistematización de experiencias demostrativas, que puedan ser socializadas para fortalecer el desarrollo del programa e igualmente para facilitar la sensibilización a otros municipios e ir generando evidencia de intervenciones en promoción de la salud.

## 4.3 Para Cº munidades Saludables

**PRIMERA FASE: Sensibilización.-** Esta etapa cº nsiste en generar el cº mprº misº e invº lucramientº de lº s principales actº res sº ciales de una cº munidad para la cº nstrucción de cº munidades saludables en la jurisdicción del establecimientº de salud. Principalmente de autº ridades y líderes cº munales cº n la finalidad de generar mayº r legitimidad y aprº piación de ella desde la etapa inicial. Incluye la sectº rización y la designación de respº nsables pº r sectº r º cº munidad.

El producto de esta primera fase será el Acta de Acuerdos y Compromisos firmada por todoslos actores sociales de la comunidad para promover y construir comunidades saludables.

***SEGUNDA FASE: Organización.-*** Esta referido principalmente a la conformación de la instancia de concertación comunal, o la incorporación y fortalecimiento de la instancia existente en la localidad. Así mismo comprende la organización del establecimiento de salud con la comunidad para construir comunidades saludables en la jurisdicción.

Al finalizar esta fase, se contará con un Acta donde conste la conformación de un Comité Multisectorial Comunal (conformado por los o algunos de los integrantes de la instancia) con responsabilidades y líneas de acciones definidas para implementar comunidades saludables.

***TERCERA FASE: Planificación Participativa.-*** En esta fase se toma el conocimiento real de la situación de salud de la comunidad, identificando las demandas o necesidades sociales, los recursos existentes: humanos, materiales, económicos y la experiencia adquirida en el abordaje a los problemas o necesidades, el censo comunal y los actores comunitarios existentes.

Todo ello facilitará la elaboración del plan comunal, la cual será construida en base a la visión comunal compartida. Es necesario, que el plan comunal sea el resultado de una construcción colectiva y participativa, la misma que deberá dar respuesta a los problemas y necesidades identificadas por la población. El plan incluye acciones de la comunidad en el autocuidado de la salud de las personas y familias como parte del desarrollo integral comunal, así como la organización del sistema de vigilancia comunal para contar con información oportuna y de calidad que facilite intervenciones frente a los factores de riesgo y determinantes de la salud en la comunidad. Igualmente incluye el diseño y planificación de proyectos comunales.

Al finalizar esta fase, deberá la comunidad contar con un plan comunal concertado, siendo el producto de esta fase. Es importante señalar que este plan deberá estar articulado al Plan de Salud Local y al Plan de Desarrollo Municipal.

***CUARTA FASE: Gestión y Ejecución -*** Este fase hace referencia a la parte central del componente y consiste en cómo la comunidad se organiza para ejecutar las acciones acordadas en el plan, que pueden ser a través del trabajo comunitario o con el apoyo de otros actores sociales públicos y privados. Incluye la gestión y negociación de los proyectos comunales acordados, con recursos locales y/o financiamiento externo.

Al finalizar esta fase deberá contarse con acciones ejecutadas, con proyectos comunales e iniciativas de desarrollo comunal en operación.

***QUINTA FASE: Seguimiento y Evaluación Participativa.-*** Consiste en el acompañamiento del avance y la evaluación de los planes comunales teniendo en cuenta los retos planteados en cada comunidad en función a los problemas identificados, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Por lo menos dos aspectos serán fundamentales considerar en la evaluación, la calificación de comunidades saludables en función a la autoevaluación de cada una las fases de implementación y al logro de los resultados del plan comunal en función a la visión comunal compartida, que contribuya en la mejora del estado de salud de la población.



# CAPÍTULO 5

## EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA



## 5.1 Evaluación y Mº nitº reº del Prº grama

Para cada fase del Programa de Municipios y Comunidades Saludables se establecerán actividades e indicadores de proceso y resultado, a fin de determinar los avances en cada fase, aplicando la evaluación participativa como proceso continuo de reflexión sobre lo que se ha emprendido y logrado, con la finalidad de orientar y modificar la acción futura. Las áreas a evaluar son: la participación social, la intersectorialidad, las políticas públicas y/o ordenanzas municipales, la sostenibilidad de los procesos entre otros, en los municipios y comunidades incorporadas al programa.

El personal de salud promoverá las evaluaciones y monitoreo presencial de las acciones de promoción desarrolladas en las comunidades y municipios incluidos en el programa.

El Ministerio de Salud ha establecido indicadores del Programa de Municipios y Comunidades Saludables, los mismos que se detallarán en la Guía Metodológica para la implementación del programa. Cada Dirección, de acuerdo a éste marco, establecerán las actividades e indicadores adaptándolos a la realidad regional.



# ANEXOS



# ANEXO N° 01

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

***Calidad de vida:*** Se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno[17].

***Calificación:*** Constituye un proceso de evaluación de la condición de saludable a un municipio o comunidad. La calificación esta basada en dos aspectos centrales. La primera, destinado a verificar la consecución y el desarrollo de todas las fases de implementación de una intervención a través de la autoevaluación de cada una de las fases, y segundo, en relación a los resultados de la fase de ejecución (el plan de la intervención), ambos determinan la calificación final de todo el proceso.

***Comunidad Saludable Calificada:*** Es aquella comunidad que habiéndose comprometido y decidido ingresar al programa de municipios y comunidades saludables, se organiza, planifica y ejecuta acciones de promoción de la salud orientadas al desarrollo de la comunidad; con autoridades, líderes comunales y otras organizaciones sociales de base, en estrecha coordinación con el gobierno local.

***Desarrollo comunal:*** Es un conjunto de acciones orientadas a la identificación de los principales problemas y su solución a través de proyectos de desarrollo local para el bienestar económico y social de individuos y familias.

***Desarrollo local:*** Es un proceso que comprende las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y éticas dirigidas hacia la promoción del desarrollo de capacidades de la localidad. Cuando se asocia a la participación ciudadana, promueve el bien común y asume el desarrollo humano buscando mejorar la calidad de vida de la población[18].

***Determinantes de la salud:*** Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. La promoción de la salud trata fundamentalmente de la acción y la abogacía destinada a abordar el conjunto de determinantes de la salud potencialmente modificables; no solamente aquellos que guardan relación con las acciones de los individuos, como los comportamientos y los estilos de vida saludables, sino también con determinantes como los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos[19].

***Espacios de concertación:*** Es la instancia de discusión, coordinación, propuesta de las acciones a tomar y vigilancia social, entre la sociedad civil y los diferentes niveles la gestión pública, para negociar y promover la toma de decisiones en aspectos que afectan la salud, la calidad de vida y el desarrollo local en general; a fin de lograr el bienestar de la población.

[17] IDEM.
[18] FOVIDA. 2003. Participación Ciudadana para el Desarrº llº Lº cal.
[19] OPS. Glº sariº . Prº mº ción de la Salud.

***Estilos de vida saludable:*** Es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales[20].

***Entornos saludables:*** Son entornos que ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprende los lugares donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, su lugar de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento[21].

***Municipio saludable calificado:*** Es aquel que se habiéndose comprometido e ingresado al programa de municipios y comunidades saludables, inicia el desarrollo de acciones en la municipalidad, en los espacios públicos con la comunidad organizada[22], autoridades e instituciones locales, estableciendo acuerdos y acciones conjuntas mediante una organización intersectorial, orientadas al desarrollo local.

***Participación:*** Es la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre temas que le conciernen, para que sea completa debe haber acceso a la información la oportunidad de estar en el proceso de diseño, planificación de acciones orientadas al desarrollo[23].

***Red social:*** Es el tejido social conformado por personas, organizaciones y/o instituciones que se articulan en base a intereses y objetivos comunes.

Redes sociales: Relaciones y vínculos sociales entre las personas que pueden facilitar el acceso o movilización del soporte social a favor de la salud[24].

***Responsabilidad social para la salud:*** Se refleja en las acciones de los responsables de la toma de decisiones tanto del sector público como privado, para establecer políticas y prácticas que promuevan y protejan la salud[25].

[20] IDEM
[21] IDEM
[22] En el programa, se entiende comunidad organizada a la población y líderes que integran organizaciones sociales, a las instituciones de la sociedad civil y las redes sociales existentes en la comunidad.
[23] BOLAÑOS. F. SUBIRIA . B 2003, Metodologías participativas: Estudio para el Proyecto: Derecho, Inclusión y Desarrollo.
[24] IDEM
[25] IDEM

# ANEXO N° 02

## CUADRO DESCRIPTIVO DE EJES TEMÁTICOS

El programa ha priorizado estos ejes temáticos comprendidos en el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud y presenta algunos ejemplos de intervenciones comunitarias y municipales:

| EJE TEMÁTICO | PROPUESTA DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS Y MUNICIPALE |
|---|---|
| HIGIENE Y AMBIENTE | ✎Promover y difundir el concepto de desarrollo sostenible y la salud como un pilar indispensable.<br>✎Higiene y cuidado del entorno en el bienestar de la comunidad.<br>✎Participación comunitaria en la vigilancia del saneamiento básico comunal.<br>✎Prácticas de higiene en toda la cadena alimentaria para la elaboración de alimentos de consumo humano.Fomento de políticas públicas regionales y locales para las practicas de higiene, que proporcionen a las personas un entorno saludable en el hogar, escuela, trabajo y comunidad.<br>✎Formar líderes ambientales para la protección de recursos locales y/o en la vigilancia de la conservación del aire, agua y suelo.<br>✎Fomentar la elaboración de diagnósticos participativos para identificar problemas ambientales locales, tales como: contaminación atmosférica, acústica y vigilancia de la cantidad y la calidad del agua, remoción de contaminantes en desagües, recolección y disposición de residuos sólidos, falta de pavimentación , acceso a ciclo vías , áreas industriales abandonadas, calidad del transporte público y cobertura de la red pública de transporte, espacios habitables.<br>✎Saneamiento básico, manejo de desechos, erosión y forestaciónuso de plaguicidas, redes de agua, eliminación de residuos sólidos y residuos líquidos. |
| ACTIVIDAD FÍSICA | Impulsar y generar políticas locales a favor de la actividad física mediante alianzas estratégicas con las Municipalidades Provinciales, Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas y privadas.<br>✎Incluir propuestas de actividad física para la comunidad según Etapas de Vida (niño, adolescente, adulto y adulto mayor) en los Planes Municipales Anuales, por ejemplo: Gimnasia, Atletismo (Caminata, Maratón, etc), Bicicletada, Torneos deportivos, Tai Chi, etc dentro de las celebraciones públicas (Día del adulto mayor, Día del Niño, Día de la Familia, Día de la Juventud, Semana Perú Lucha contra el Cáncer, Día de la Hipertensión Arterial, Día de la Diabetes, Día de la Persona con Discapacidad, etc).<br>✎Desarrollar, fortalecer y brindar sostenibilidad a Programas de actividad física para los trabajadores de los municipios, por ejemplo torneos deportivos.<br>✎Promover la Actividad Física en los usuarios de los servicios que ofrece el Municipio.<br>✎Brindar espacios y/o escenarios públicos a la población de su jurisdicción donde se expresen actividades deportivas.<br>✎Asignación presupuestal anual y búsqueda de financiamiento para las diversas acciones y actividades relacionadas a la actividad física. |
| SEGURIDAD VIAL Y CULTURA DE TRANSITO | ✎Desarrollo de alianzas con los ministerios de Salud, Transporte, Interior, y entidades que trabajan el tema para desarrollar programas intersectoriales en cada distrito y provincia.<br>✎Desarrollar programas de educación vial en las escuelas en el nivel preescolar, primario, secundario; y en las universidades e institutos; también a los peatones, pasajeros y conductores.<br>✎Fomento de uso de formas más segura para desplazarse como el uso de bicicletas. Mejorar o crear ciclo vías.<br>✎Promoción intersectorial de respeto a reglas y normas básicas referentes al tránsito vehicular y peatonal; límite de velocidad, manejo de prevención del problema de fatiga del conductor, uso de cinturón de seguridad y sillas infantiles, uso de casco en vehículos de dos ruedas, el no uso de celulares, etc.<br>✎Establecer mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia en el cumplimiento de mantenimiento técnico y dispositivos de seguridad y emergencia, de vehículos de transporte público y escolar; así como la vigilancia y promoción de conductas adecuadas en el tránsito vehicular y peatonal.<br>✎Fomentar la promulgación de ordenanzas municipales que apoyen la seguridad vial en los lugares que congreguen población tales como: entidades educativas, recreativas, culturales, deportivas y otros. |

| EJE TEMÁTICO | PROPUESTA DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS Y MUNICIPAL |
|---|---|
| PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, BUEN TRATO Y CULTURA DE PAZ | ✎Desarrollar acciones de promoción de valores y relaciones humanas saludables, espacios y oportunidades de participación y desarrollo integral.<br>✎Incorporar en los programas de jóvenes y adolescentes la promoción de habilidades psicosociales y vínculos saludables.<br>✎Incorporar en los programas municipales, a las poblaciones afectadas por la violencia política y desastres. |

Sin embargo, existen otros ejes temáticos importantes que se pueden abordar desde el escenario municipal o comunitario como son:

| EJE TEMÁTICO | INTERVENCIONES COMUNITARIAS Y MUNICIPALES |
|---|---|
| ALIMENTACIÓN Y NUTRICION | ✎Elaborar un diagnóstico participativo de la situación alimentaria y nutricional en cada municipio.<br>✎Desarrollar actividades de capacitación a las madres del vaso de leche en alimentación y nutrición saludable, según etapas de vida y espacios de intervención; así como al personal de los municipios.<br>✎Difundir mensajes educativos a través de los medios de comunicación del municipio y promover acciones conjuntas de sensibilización a la población en el día mundial de la alimentación, día de la tierra, del medio ambiente, etc.<br>✎Fomentar la participación en las mesas de concertación a nivel distrital y provincial, pudiéndose articular con proyectos de nutrición y seguridad alimentaria promovidos por diferentes ONG's, y por el Ministerio de Agricultura como PRONAMACHS.<br>✎Desarrollar proyectos productivos alimentarios en el distrito/provincia, como: horticultura, fruticultura, elaboración de compotas, apicultura, crianza de animales menores, etc.<br>✎Realizar abogacía para la emisión de ordenanzas municipales para el control adecuado del expendio de alimentos en mercados y restaurantes.<br>✎Participar en la elaboración de los presupuestos participativos donde se incluya una partida para la promoción de una alimentación y nutrición saludable.<br>✎Participar en la vigilancia de la higiene y preparación de los alimentos de los programas sociales: Wawa Wasi, comedores populares, desayunos escolares, vaso de leche, en coordinación con otros órganos competentes del Ministerio de Salud etc.<br>✎Hacer abogacía con los dirigentes de los mercados de la zona y los dueños de puestos, para promover «mercados saludables».<br>✎Promover a nivel distrital/provincial el establecimiento de un sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria en base a indicadores específicos. |
| HABILIDADES PARA LA VIDA | ✎Promover y difundir acciones hacia el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos en niños, adolescentes y jóvenes, adopción de valores y respeto de las personas, comunicación intrafamiliar, sensibilización de su responsabilidad hacia el desarrollo de su entorno social y capacidades para la generación del desarrollo.<br>✎A través de los programas municipales y en las iniciativas comunales se puede realizar abogacía y movilización de los líderes y actores claves de la comunidad y del entorno local para promover acciones para fortalecer las habilidades para la vida de la población.<br>✎Establecer alianzas estratégicas intersectoriales.<br>✎Desarrollar acciones de comunicación, educación en salud y habilidades para la vida a nivel de municipios, organizaciones sociales, escuelas, universidades y centros laborales. |

Igualmente, a nivel local se pueden desarrollar otros temas que respondan a las necesidades municipales y comunales definidos en consenso con la población y autoridades.

# BIBLIOGRAFÍA

Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002 - 2012 y principios fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio, Agosto 2001 - Julio 2006. Ministerio de Salud.

Municipios Saludables. R. Pareja. Febrero, 2003. Catalyst Consortium.

Municipios y Comunidades Saludables. Guía de los Alcaldes para promover Calidad de Vida. 2002. OPS.

Cuaderno de Promoción de la Salud N° 5 Red de Municipios y Comunidades Saludables. 2003. OPS.

Cuaderno de Promoción de la Salud N° 11 Construyendo Barrios Saludables. Cajamarca, 2002 - 2003. Enero, 2004. OPS.

Lineamientos Estratégicos para la Implementación del Sistema de Vigilancia Comunal en Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Agosto, 2003. Ministerio de Salud.

Guía metodológica para la implementación de Comunidades Saludables. 2004. Proyecto Amares.

Guía Metº dº lógica para Implementar Sistema de Vigilancia Cº munal de Salud SÍVICO.
2003. Dirección Regiº nal de Salud Ancash.

Intercambio de Experiencias en Municipios y Comunidades Saludables en el Perú. 2000. OPS.

Municipios Saludables. Comunicación para la Salud N° 11. 1997. OPS/OMS.

Programa de Acción. Comunidades Saludables. Primera Edición 2002. Secretaría de Salud de México D.F.

Informe Memoria: Red de Municipios y Comunidades Saludables de Lima y Callao, Taller de Planificación Estratégica.2001.

Salud desde el Municipio: Una Estrategia para el Desarrollo. Sotelo, Juan M. y Rocabado, Fernando. 1994.

Consejo Nacional de Salud. Propuesta de Lineamientos de Política de Promoción de la Salud. 2003. (Documento de Trabajo).

Participación Ciudadana para el Desarrollo Local. Editora Linea y Punto FOVIDA.SAC.2003.

Manual de Gestión Municipal. Rudesindo Vega et al. 2000.

Metodologías participativas: Estudio para el Proyecto: Derecho, Inclusión y Desarrollo. BOLAÑOS. F. SUBIRIA . B 2003.

Guías y Herramientas para la Incidencia Política. Manual de Referencia para gerentes de Programas. CARE. 2001.